**جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *** **طلب علاج أول مرة / متردد**

**إسم المريض رباعياً :** امينه محمد عبدالسلام دياب
**المحافظة :** المنوفيه **الحي / المدينة :** شبين الكوم **العنوان :** ----------
**رقم البطاقة :** 25110201700161 **رقم التليفون :** 01010021825 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 23-10-2026
**العمر(تاريخ الميلاد) :** 20-10-1951 **المهنة :** ربه منزل

## الإقرار

**أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك**

**الإخصائي الاجتماعي** **المقر بما فيه**
**التوقيع:**(----------) **التوقيع:**(----------)

**التشخيص الإكلينيكي :** سرطان بالثدي (مبادرة)
**نتائج الأبحاث :** (مرفق)
**التشخيص النهائي :** سرطان بالثدي (مبادرة)
**خطة العلاج :** أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام
**التعليق على التشخيص :** ----------

## تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

**الاسم:** د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
**الاسم:** د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
**الاسم:** د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

**أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.**
**كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.**

**تعتمد صحة البيانات المرفقة**
**رئيس اللجنة و مدير المستشفي.**

**تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.**

## أعضاء اللجنة

**ا.د/** ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

## قرار اللجنة

**التشخيص النهائي :** ----------
**خطة العلاج :** ----------
**المستشفي :** ----------**قسم :** ----------
**جهة العلاج :** ----------**نفقات :** ----------
**ملاحظات :** ----------

| رئيس | مدير عام | ختم |
|---|---|---|
| المجلس الطبي المتخصص | مديرية الشئون الصحية | شعار الجمهورية |

Name: امينه محمد عبدالسلام دياب
National ID: 25110201700161

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

## تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

| | |
|---|---|
| إيماء للطلب المقدم من | بشأن تقرير طبي للمريض |
| بقسم: | رقم طبي: |

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

| | |
|---|---|
| تاريخ وساعة الدخول :<br>-- --:-- yyyy-mm-dd | تاريخ وساعة الخروج :<br>PM 01:17 05-07-2026 |

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

| | |
|---|---|
| التاريخ :<br>05-07-2026 | الوقت :<br>-- --:-- |
| | الطبيب المعالج :<br>د/شيماء لاشين |


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
امينه
محمد عبدالسلام دياب
كفر الشيخ خليل
مركز شبين الكوم - المنوفية
٢٥١٠٢٠١٧٠٠١٦١
LN7585544


٢٥١١٠٢٠١٧٠٠١٦١
٢٠٢٦/٠١
ربة منزل
أنثى
مسلمة
أرملة
١٢
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٣/٠١/٠٤

# الكرنك للأشعة والتحاليل
# Karnak Scan & Lab

Name: Mrs. Amina Mohamed Abdel Salam
Date: 10/09/ 2026
Ref. By: Prof. Dr. Assem Asiouty

## BILATERAL MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASONOGRAPHY REVEALED:-

**CLINICAL SUMMARY:**

- 4 years history of right breast lump sensation, with recent skin extension. Diabetic.

**FINDINGS: -**

- Normal skin thickness and contour with normal nipple/ areola complex and subcutaneous tissues.
- Heterogeneous fibro-glandular element on both sides.
- **The right breast, at the outer central region shows a large speculated dense mass lesion. In ultrasound, along 9 O'clock orientation (site of skin lesion) it is seen as a large ill-defined hypoechoic mass lesion, with increased internal vascularity, reaching about 9x4x5 cm. it is seen communicating with dilated retro areolar ducts (4.2 mm). it is seen invading the overlying thickened skin (4.5 mm)**
- **The left breast, at the LOQ/ retro areolar shows asymmetrical/ irregular dense lesion. In ultrasound, along LOQ, about 2 cm from the nipple, an area of distorted parenchyma, reaching about 5x4.8x4.3 cm is noted, with multiple related dilated retro areolar ducts (4.5 mm), and filled with echogenic non mobile contents.**
- No suspicious micro-calcifications seen.
- Bilateral axillary reactive lymph nodes with preserved fatty hila, **with several right axilla (level I), prominent lymph nodes with eccentric effaced fatty hila and cortical thickness reaching 9 mm.**

**OPINION: -.**

- Right breast outer central malignant looking mass lesion with overlying skin ulceration, possible intraductal extension as well as pathological right axillary lymph nodes (BIRADS 4c).
- Left breast LOQ/ retro areolar area of distorted parenchyma with related duct ectasia as described (BIRADS 4a).
- For clinical correlation, better dynamic breast MRI (to assess the diseased extension) followed by trucut needle biopsy.

Dr. Mariam Fikry Mor


83 Ain Shams St. - Cairo
24 993 133 - 24 923 702
012 22 353 572 - 010 34 414 830 - 011 53 388 880
010 29 461 757
https://www.facebook.com/karnakscan

٨٣ شارع عين شمس - أمام فرع أورنج - القاهرة
٢٤٩٩٣١٣٣ - ٢٤٩٢٣٧٠٢
٠١١٥٣٣٨٨٨٨٠ - ٠١٠٣٤١٤١٨٣٠ - ٠١٢٢٢٣٥٣٥٧٢
٠١٠٢٩٤٦١٧٥٧




Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Patient Name** | امينه محمد عبدالسلام دياب | **Case No.** | **439538** |
| **Sex/Age** | **Female 75 Y** | **Patient No.** | **30956** |
| **Registered Date** | **05/10/2026 11:58:21 AM** | **Referred By Dr.** | **Interventional Radiology** |
| **Validation Date** | **18/10/2026 09:34:44 AM** | **Branch** | **Gustave Roussy** |
| **Reporting Date** | **22/10/2026 01:07:29 PM** | **Pathology No.** | **3253/26** |

**- PR: Positive (score 8/8).**
**- Her2: Low (score 1+).**
**- Ki67: 35%.**

***Scoring system: "ER, PR"**
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
**** Scoring system: "Her2"***
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

***Signature***
***Prof. Dr. Dalia Abu El Fadl.***





GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Patient Name** | امينه محمد عبدالسلام دياب | **Case No.** | **439538** |
| **Sex/Age** | **Female 75 Y** | **Patient No.** | **30956** |
| **Registered Date** | **05/10/2026 11:58:21 AM** | **Referred By Dr.** | **Interventional Radiology** |
| **Validation Date** | **18/10/2026 09:34:44 AM** | **Branch** | **Gustave Roussy** |
| **Reporting Date** | **22/10/2026 01:07:29 PM** | **Pathology No.** | **3253/26** |

# Pathology Report

**Clinical Data:** Right breast mass.

**Nature of Specimen**: Tru-cut biopsy, collected on 5/10/2026, at 11:58 am. Cold ischemia time is 20 seconds.

**Gross Examination:**
Fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.5 cm & 1.2 cm long, totally submitted.

**Technique:**
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

**Microscopic examination:**
**-Histologic type:** Invasive duct carcinoma
**- Histologic grade: 2 (**differentiation 2, pleomorphism 2, mitosis 2)
**- Ductal carcinoma in situ:** Absent.
**- Microcalcification:** Absent.
**- Angioinvasion:** Absent.
**- Perineural invasion:** Absent.
**- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs):** Mild.

**Results:**
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 100% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Weak membrane reaction in tumor cells (score 1).
- Ki67%: 35%.

**Conclusion:**
**Right breast mass, Tru-cut biopsy:**
**- Invasive duct carcinoma, (NST) Grade 2.**
**IPT:**
**- ER: Positive (score 8/8).**



Pathology Report [[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

HEALTH INSURANCE ORGANIZATION
CENTER DEPARTMENT OF
INFORMATION SYSTEM AND DIGITAL
TRANSFORMATION

الهيئة العامة للتامين الصحى
الادارة المركزية للنظم المعلومات و التحول الرقمى

رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار :22-9-2026 جهه الاصدار :فرع القاهرة

الى من يهمه الامر .....

الهيئه العامة للتامين الصحى تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانون 25 لسنه 1977 "القوى العامله والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنه 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنه 2012 " الاطفال دون السن المدرسى" وقانون رقم 23 لسنه 2012 الخاص بالمرأة المعيله .

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه

وطيقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى

والبحث تبين أن

السيد (ة) امينه محمد عبدالسلام بطاقة رقم 25110201700161

تليفون رقم: 01000000000

وطبقا الى خطاب من التأمينات الإجتماعية يفيد عدم الأنتفاع .

يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتامين الصحى صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحى حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحى الشامل

وشكرا

تاريخ الطباعه :22-9-2026

الموظف المختص
دنيا اشرف

افادة مركز نظم المعلومات
يعتمد،،،

مسلسل 2086966

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حاله تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزراة التربية و التعليم

الادارة المركزية لنظم المعلومات و التحول الرقمى

FISH Analysis
[[DOCTYPE:FISH_ANALYSIS]]

# الكرنك للأشعة والتحاليل
# Karnak Scan & Lab

Name: Mrs. Amina Mohamed Abdel Salam
Date: 10/09/ 2026
Ref. By: Prof. Dr. Assem Asiouty

## BILATERAL MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASONOGRAPHY REVEALED:-

### CLINICAL SUMMARY:

- 4 years history of right breast lump sensation, with recent skin extension. Diabetic.

### FINDINGS: -

- Normal skin thickness and contour with normal nipple/ areola complex and subcutaneous tissues.
- Heterogeneous fibro-glandular element on both sides.
- **The right breast, at the outer central region shows a large speculated dense mass lesion. In ultrasound, along 9 O'clock orientation (site of skin lesion) it is seen as a large ill-defined hypoechoic mass lesion, with increased internal vascularity, reaching about 9x4x5 cm. it is seen communicating with dilated retro areolar ducts (4.2 mm). it is seen invading the overlying thickened skin (4.5 mm)**
- **The left breast, at the LOQ/ retro areolar shows asymmetrical/ irregular dense lesion. In ultrasound, along LOQ, about 2 cm from the nipple, an area of distorted parenchyma, reaching about 5x4.8x4.3 cm is noted, with multiple related dilated retro areolar ducts (4.5 mm), and filled with echogenic non mobile contents.**
- No suspicious micro-calcifications seen.
- Bilateral axillary reactive lymph nodes with preserved fatty hila, **with several right axilla (level I), prominent lymph nodes with eccentric effaced fatty hila and cortical thickness reaching 9 mm.**

### OPINION: -.

- Right breast outer central malignant looking mass lesion with overlying skin ulceration, possible intraductal extension as well as pathological right axillary lymph nodes (BIRADS 4c).
- Left breast LOQ/ retro areolar area of distorted parenchyma with related duct ectasia as described (BIRADS 4a).
- For clinical correlation, better dynamic breast MRI (to assess the diseased extension) followed by trucut needle biopsy.

Dr. Mariam Fikry Mos...


83 Ain Shams St. - Cairo
24 993 133 - 24 923 702
012 22 353 572 - 010 34 414 830 - 011 53 388 880
010 29 461 757
https://www.facebook.com/karnakscan
karnakscanrec@gmail.com

٨٣ شارع عين شمس – أمام فرع أورنج – القاهرة
٢٤٩٢٣٧٠٢ – ٢٤٩٩٣١٣٣
٠١٢٢٢٣٥٣٥٧٢ – ٠١٠٣٤٤١٤٨٣٠ – ٠١١٥٣٣٨٨٨٨٠
٠١٠٢٩٤٦١٧٥٧



Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]